SESIÓN PRÁCTICA 1

CURSO 2026/2027
PSICOPATOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE

Enunciado: CASO REAL. APRENDIZAJE BASADO EN CASOS

Contenido relacionado con la actividad: UNIDAD 2

Objetivos a lograr:

- Describir la problemática relacionada con el caso de estudio.
- Presentar una o más soluciones o respuestas razonables y justificadas para la resolución de la problemática planteada en el caso.

Observaciones o criterios a tener en cuenta:

- La actividad entregada debe cumplir con las indicaciones facilitadas, entregarse en tiempo y forma a través del campus virtual Blackboard en el espacio correspondiente e incluir bibliografía y la declaración del uso de herramientas digitales y no plagio firmada. Debe estar igualmente identificada con nombre, apellidos y DNI del estudiante.
- Seleccionar solamente 1 de los 3 casos prácticos. Sólo debe responder las preguntas en base a 1 caso seleccionado libremente.
- Debe justificar la elección del caso.

Tipo de evidencia a subir: *Documento escrito y entregado únicamente en formato .PDF*

Extensión: *máximo 2 hojas/páginas/folios que contengan el desarrollo de la actividad*

Tipo de letra y formato: *Calibri 12 negro, justificado y con interlineado sencillo*

Herramientas o asistentes digitales permitidas: *No se permite asistencia digital*

Fecha recomendada de entrega: máx. 72h desde *la fecha de la sesión práctica 1 (3era sesión de la asignatura)*

Especificaciones para el estudiante que no participe de forma síncrona en la sesión:

- Lee atentamente cada uno de los casos que se presentan a continuación.
- Selecciona únicamente uno de los casos para desarrollar la actividad práctica.
- Responde a las dos preguntas planteadas.
- Justifica tu elección del caso.

CASO 1.

Lucía tiene 5 años y está escolarizada en Infantil. Su tutora observa que utiliza frases muy cortas para su edad, tiene un vocabulario reducido y presenta dificultades para contar lo que ha hecho durante el fin de semana. Cuando explica una historia a partir de imágenes, menciona algunos personajes y acciones, pero le cuesta organizar y enlazar los acontecimientos. Su audición está dentro de los parámetros esperados.

SESIÓN PRÁCTICA 1

CURSO 2026/2027
PSICOPATOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE

CASO 2.
Álvaro tiene 6 años y presenta dificultades para pronunciar algunos sonidos del habla. Su tutora señala que en ocasiones sus compañeros no comprenden algunas palabras que dice. En el aula, Álvaro participa normalmente en las conversaciones y comprende las instrucciones, pero determinados errores de pronunciación afectan a la claridad de su habla.

CASO 3.
Mario tiene 7 años y desde hace varios meses presenta repeticiones de sonidos y sílabas y algunos bloqueos al hablar. En ocasiones aumenta la tensión antes de producir una palabra y evita participar oralmente delante de toda la clase. Su tutora observa que estas dificultades son especialmente evidentes cuando tiene que hablar delante de sus compañeros.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué trastorno estudiado en la unidad 2 podría estar relacionado con las dificultades que presenta el caso que usted ha seleccionado? Justifica tu respuesta a partir de la información proporcionada y la información teórica estudiada.
2. Como Maestro/a de Audición y Lenguaje, diseña una actividad concreta para trabajar una de las dificultades que presenta el caso. Explica el objetivo de la actividad, cómo la realizarías (descripción) y qué material utilizarías.

No olvidar: Justificar la elección del caso.

SESIÓN PRÁCTICA 1

CURSO 2026/2027
PSICOPATOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE

Nombre y Apellidos del estudiante: Pablo Hernández Rizo

DNI: 45843762R

Desarrollo de la actividad:

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL CASO SELECCIONADO (CASO 3: MARIO, 7 AÑOS)

Se selecciona el **Caso 3 (Mario, 7 años)** por la gran repercusión clínica, emocional y escolar que conlleva la tartamudez infantil en Educación Primaria. Aunque el Trastorno de la Fluidez de Inicio en la Infancia presenta una prevalencia del 0,5% al 1,5% escolar (Artigas-Pallarès et al., 2022) y un elevado índice de heredabilidad genética de 0,7 (Rupérez et al., 2022), cuando persiste a los 7 años acompañado de tensión muscular anticipatoria y conductas de evitación en el aula existe un alto riesgo de cronificación (20% de los casos iniciales), desencadenando ansiedad comunicativa, logofobia y baja autoestima si no se aborda de forma temprana y coordinada desde Audición y Lenguaje.

1. IDENTIFICACIÓN DEL TRASTORNO Y JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y DIFERENCIAL

De acuerdo con la Unidad 2 (Secciones 2.5 y 3.5), el cuadro de Mario se corresponde con un **Trastorno de la Fluidez de Inicio en la Infancia (TFI)**, denominado clínicamente **tartamudez infantil** (anteriormente *disfemia*), catalogado dentro de los *Trastornos de la Comunicación* en el DSM-5 (APA, 2013) y fundamentado por Rupérez et al. (2022), Coll-Florit et al. (2014) y Susanibar et al. (2016).

La justificación diagnóstica se basa en los criterios del DSM-5 y en los parámetros diferenciales de la **Tabla 3 de la Unidad 2 (*Disfluencias evolutivas vs. Tartamudez infantil*, Rupérez et al., 2022)**:

a) Alteración persistente en la fluidez y organización temporal del habla: Según el DSM-5 y Susanibar et al. (2016), el TFI supone una ruptura involuntaria del flujo del habla inadecuada para la edad. Mario manifiesta los signos nucleares del cuadro: *«repeticiones de sonidos y sílabas»* y *«algunos bloqueos al hablar»* (interrupciones audibles o silenciosas por incoordinación pneumofonoarticulatoria).

b) Diagnóstico Diferencial frente a la Disfluencia Evolutiva (Tabla 3, Rupérez et al., 2022): Es fundamental distinguir la disfluencia evolutiva (fisiológica entre los 2,5 y 5 años, con un 80% de remisión espontánea) de la **tartamudez infantil instaurada** de Mario. Aplicando la Tabla 3 de la Unidad 2, Mario cumple todos los indicadores de tartamudez infantil: (1) *Edad:* tiene **7 años** (etapa 6-7 años frente a los 2,5-5 años evolutivos); (2) *Duración:* persiste «desde hace varios meses» con carácter intermitente agravado por la presión social; (3) *Tipo de disfluencias:* presenta repeticiones de sonidos/sílabas y **bloqueos** (ausentes en la disfluencia evolutiva); (4) *Tensión muscular:* **«aumenta la tensión antes de producir una palabra»** (esfuerzo físico evidente, inexistente en la forma evolutiva); y (5) *Evitación:* **«evita participar oralmente delante de toda la clase»**, evidenciando ansiedad anticipatoria y evitación situacional frente a sus compañeros.

c) Diagnóstico Diferencial frente a otros trastornos de la Unidad 2: Se descartan el **Trastorno del Lenguaje (TL)** y el **Trastorno de los Sonidos del Habla (TSH)** porque Mario sabe exactamente qué quiere decir (indemnidad léxica, morfosintáctica y fonológica), sufriendo una pérdida involuntaria de sincronía temporal (Coll-Florit et al., 2014). Igualmente, se descartan la **Disfonía espasmódica** (Sanz et al., 2015) y la **Disartria** por ausencia de distonía laríngea focal o lesión neurológica motora.

2. DISEÑO DE UNA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN DESDE AUDICIÓN Y LENGUAJE

Título: *«El Camino de la Tortuga y el Semáforo del Habla Suave»* (Entrenamiento de inicio fonatorio suave, enlentecimiento prosódico y desensibilización gradual de la evitación en el aula).

SESIÓN PRÁCTICA 1

CURSO 2026/2027
PSICOPATOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE

Dificultad trabajada y Objetivos: Aborda el exceso de tensión previa, los bloqueos/repeticiones y la evitación a hablar frente a la clase. Sus objetivos son: (1) Reducir la tensión muscular glótica y labial entrenando la respiración costodiafragmática, el ataque vocal blando (inicio suave) y la prolongación vocálica controlada; y (2) Extinguir la evitación oral en el aula mediante una jerarquía de participación comunicativa gradual y segura.

Descripción metodológica (Sesión tipo de 35 minutos en aula de AL y transferencia al aula):

- **Fase 1. Distensión muscular e inicio suave con «El Muñeco de Nieve» (8 min):** Para desactivar el aumento de tensión previo a la palabra, se entrena el contraste neuromuscular de Koeppen: tensar mandíbula, labios y hombros como un «bloque de hielo» y soltar el aire suavemente destensando como un «muñeco de nieve al sol». A continuación, frente a una cinta de seda, Mario practica el **inicio fonatorio suave** soltando una leve espiración antes de deslizar la primera vocal de la palabra sin golpe glótico ni bloqueo.
- **Fase 2. Habla enlentecida en «El Tablero de la Tortuga Sabia» (15 min):** Sobre un tablero con un recorrido en forma de olas suaves y «oasis de parada», el maestro/a de AL ofrece un modelo de habla pausada, rítmica y sin prisas. Primero se realizan emisiones en **habla simultánea (en coro)** y lectura rítmica de secuencias pictográficas (lo que suprime los bloqueos de inmediato al sincronizar la planificación temporal); después, Mario desliza su dedo por una tira táctil de terciopelo («el tobogán de las palabras») alargando suavemente la sílaba inicial en juegos de descripciones sin presión de tiempo.
- **Fase 3. Transferencia al aula con «La Tarjeta Semáforo VIP» (12 min):** Para superar la evitación a hablar delante de sus compañeros, se acuerda con Mario y su tutora una exposición gradual en tres pasos: 1.º Hablar en pareja con un compañero de confianza; 2.º Intervenir en grupo cooperativo de 4 alumnos; y 3.º Participar en gran grupo usando la «Tarjeta Semáforo VIP» (acuerdo privado con la tutora: Mario coloca la tarjeta en verde en su mesa cuando desea intervenir, la tutora le anticipa la pregunta previamente para evitar la tensión sorpresiva, elimina toda prisa y valora siempre el contenido de su mensaje y nunca la forma).

Materiales utilizados: (1) Tarjetas visuales de relajación (Hielo/Sol) y cintas de seda de control espiratorio; (2) Tablero manipulativo «El Camino de la Tortuga» con curvas prosódicas y pausas; (3) Regleta táctil de terciopelo para inicio fonatorio suave; y (4) «Tarjeta Semáforo VIP» de coordinación AL-tutora-alumno.

Bibliografía:

American Psychiatric Association. (2013). *DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (5.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.

Artigas-Pallarès, J., Pérez, I. P., y Mallofré, E. V. (2022). Trastornos del lenguaje. *Pediatría Integral*, 7, 12.

Coll-Florit, M., Vila-Rovira, J. M., Aguado, G., Fernández-Zúñiga, A., Gambra, S., y Perelló, E. (2014). *Trastornos del habla y de la voz*. Editorial UOC.

Rupérez, A., Ramos, I., Machado, I., Fernández, D., Gortazar, M., y Aguilera, S. (2022). Trastornos del lenguaje, del habla y de la comunicación. Conceptos, clasificación y clínica. *Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Pediatría*, 1(1), 19-30.

Sanz, L., Rodríguez, M., Bau, P., y Rivera, T. (2015). Disfonía. *Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado*, 11(91), 5433-5444.

Susanibar, F., Dioses, A., Marchesan, I., Guzmán, M., Leal, G., Guitar, B., y Junqueira, A. (2016). *Trastornos del habla: de los fundamentos a la evaluación*. Giunti EOS.

Valera, J. A. A. (2017). Trastornos de la comunicación desde el DSM-V. La necesidad de diagnósticos diferenciales. *Cuadernos de Neuropsicología*, 11(1), 144-156.

SESIÓN PRÁCTICA 1

CURSO 2026/2027
PSICOPATOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE

DECLARACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS Y ASISTENTES DIGITALES

Y NO PLAGIO.

[X] En la realización de este trabajo no se han empleado herramientas digitales o asistentes de inteligencia artificial.

[ ] En la realización de este trabajo, se han empleado herramientas digitales y asistentes de inteligencia artificial de manera responsable en distintas fases del proceso.

A continuación, se señalan:
Características empleadas:

Herramienta utilizada:	
Versión o fecha de consulta:	

Breve descripción del uso realizado si corresponde en cada una de estas opciones:

Generación de texto:	*Se utilizó (citar sistema y versión) como asistente en la identificación de artículos, garantizando siempre la verificación de fuentes.*
Reformulación:	
Traducción/corrección:	*En la redacción del documento, se utilizó (citar sistema y versión) para la corrección gramatical y de estilo.*
Sugerencia de estructura:	
Apoyo metodológico:	
Otros:	

[X] En todo momento, se ha mantenido el criterio académico y se ha supervisado que el uso de estas herramientas no comprometa la originalidad ni la calidad del trabajo.

[X] Asimismo, es fruto de mi trabajo personal, que no copio, que no utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones diversas, sacadas de cualquier obra, artículo, memoria, etc., (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía.

De igual modo, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos extremos es objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden.

Nom **Pablo Hernández Rizo**
DNI: **45843762R**
Firm *Firmado electrónicamente: Pablo Hernández Rizo*